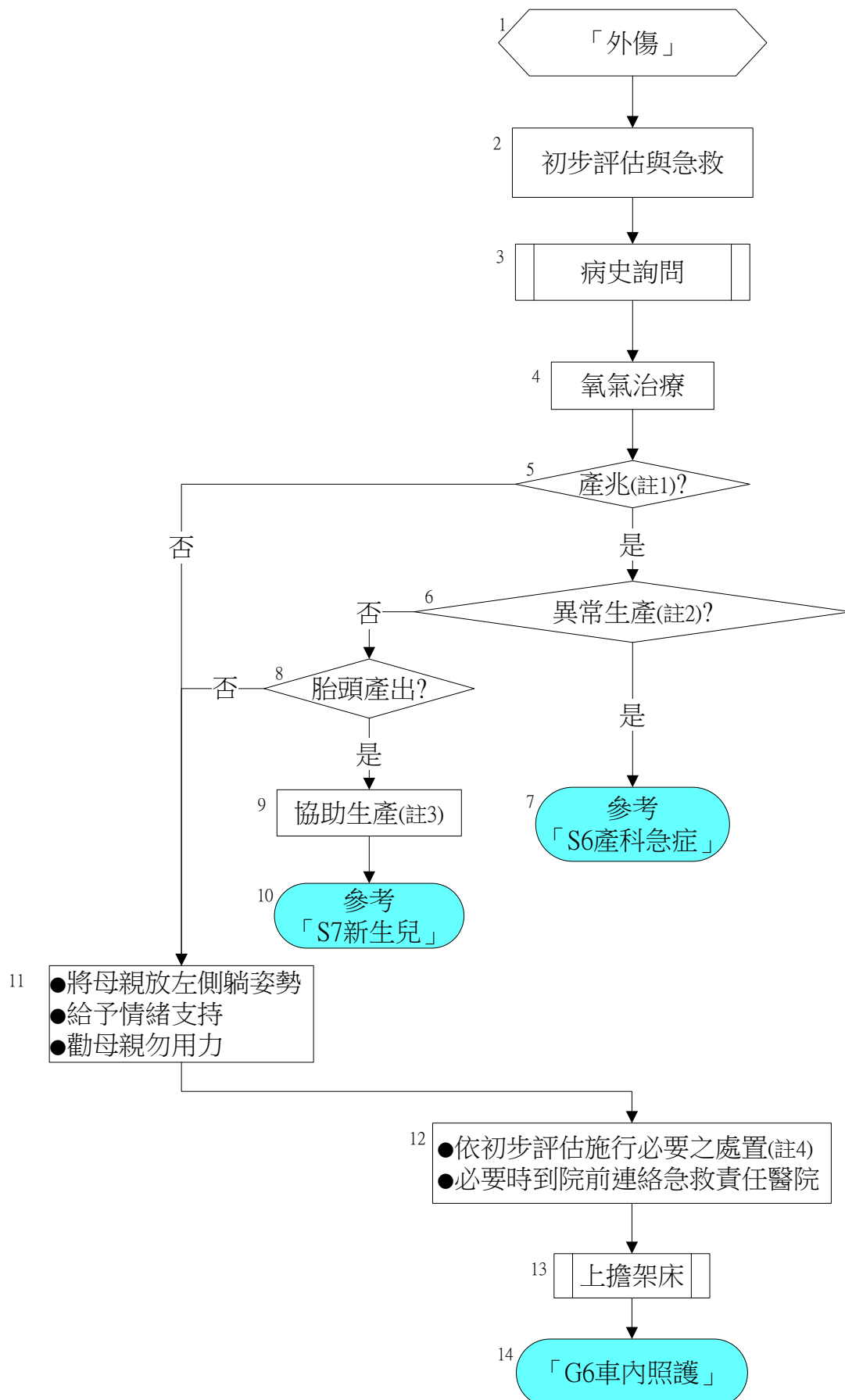


S5 自然生產

程 序



要 旨

- 一、懷孕第38週至40週生產期間自然生產，適用本程序。
- 二、救護人員在搬運前，須注意孕婦是否為3~5分鐘規律陣痛(2次陣痛之間隔小於5分鐘)，如經產婦可能隨時會產出，要檢視胎頭是否有產出。
- 三、當EMT到達現場孕婦停止疼痛後再次發生陣痛，或報案至EMT到達持續疼痛時，應小心孕婦之生命徵象。孕婦規律陣痛時應檢視胎頭有無產出。

註 解

註1>

產兆包含：破水、落紅、宮縮及陣痛等。

註2>

異常生產係指發現臍帶脫垂、臍帶繞頸或臀位生產。

- 一、臍帶脫垂：是指羊膜破裂後，臍帶滑脫至胎兒先露部位的前端，位於子宮頸口或陰道內。
- 二、臍帶繞頸：臍帶常會纏繞住胎兒身體的一部分，尤其是頸部，此時就稱為「臍帶繞頸」。
- 三、臀位生產：是指胎兒以臀部（buttocks，breech）為先露部位；又可分為完全（complete），直腿（frank），足式（footling）及膝式（kneeling）等4種型式。

註3>

- 一、將產婦以擺成平躺、兩膝彎曲、兩大腿張開之姿勢。
- 二、若先前未給氧者，此時應給予氧氣治療。並請產婦哈氣、勿用力。
- 三、打開生產包，並以無菌技術戴上無菌手套。
- 四、將無菌治療巾墊於產婦臀部下方。
- 五、一手保護胎頭但切勿阻止其產出、另一手。請產婦用力或旁人協助輕壓產婦腹部，此時胎兒將順著產道向下、產出頭頸部。
- 六、當胎兒頭頸部已產出時，應注意有無臍帶繞頸，若有則排除之(以順時針或是逆時針解除臍帶繞頸)。
- 七、以雙手掌固定頭頸部引導向下先讓上方肩膀產出。
- 八、再上方肩膀以齒骨聯合為支點向上牽引產出下肩膀。由於新生兒體多濕滑，應小心抓

緊。

九、視情況以吸球抽吸口鼻。

十、以乾的紗布或被單擦拭胎兒全身。

十一、**延遲夾臍帶（60秒以上）**，以2個臍帶夾（或兩支止血鉗）夾2處臍帶，第1處離肚臍5-10公分(約1個拳頭之距離)夾上臍帶夾，第二處離第1處5-10公分(約1個拳頭之距離)夾上臍帶夾。

十二、以摩擦背部或刺激腳底板方式刺激胎兒，但勿將胎兒倒置。

十三、若胎兒有窘迫狀況，則進行胎兒急救；若胎兒無窘迫狀況，則以乾的無菌治療巾包裹胎兒並保暖，並將胎兒交給母親，讓母親抱著。

註4>

一、如有抽搐（參見【**M4抽搐**】），維持呼吸道暢通，保護母親勿受傷，並給予適當氧氣治療。

二、如有產後大出血，考慮大口徑輸液，EMTP可考慮予以Tranexsamic acid治療（參見【**T6外傷性休克**】之（註 3））。